EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 78313
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-02-01 12:27:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: JORGE ALFONSO IRRIBARRA MEJIA			RUN	: 4.729.189-5
F.Nac	: 17-10-1941	Edad	: 82 AÑOS, 3 MESES	Género	: Masculino
Dirección	: BALMACEDA 0290			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 996873225		
Fecha Ingreso	: 2023-12-24	Fecha Egreso	: 2024-02-01 12:27:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. I50.0-INSUFICIENCIA CARD?ACA CONGESTIVA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

INSUFICIENCIA RESPIRATORIA RESUELTA
ITU TRATADA
EMPIEMA PLEURAL DER DRENADO
INSUFICIENCIA CARDIACA CON FE DEPRIMIDA
CARDIOPATIA CORONARIA
PORTADOR MARCAPASO
HIPERTENSION ARTERIAL
DIABETES MELLITUS
ENFERMEDAD RENAL CRONICA
HIPERPLASIA PROSTATICA
DAÑO HEPATICO CRONICO

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. J90-J94-OTRAS ENFERMEDADES DE LA PLEURA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente con antecedentes de IC, Cardiopatia coronaria, HTA, DM Tipo 2 NIR, DHC Child B score 7, ERC Etapa III, Usuario de Marcapasos instalado 2015 aparentemente por FA Bloqueda,
Ingresa en 24/12/2023 en el contexto de de dolor toracico asociado a disnea. Estudio en SU evidencia derrame pleural derecho moderado, inicialmente se maneja como Paraneumonico más manejo depletivo, posteriormente evaluado por Cirugia se instala SEP (09/01/24 – 15/01/24) .Por evolucion torpida tras retiro de SEP se realiza AngioTC 16/01: "Impresiona negativo para TEP. Cardiomegalia y signos de HT pulmonar. Signos de congestión pulmonar. Leve derrame pleural derecho loculado, asociado consolidación atelectásica parcial del lóbulo inferior. Leve derrame pleural derecho loculado, asociado consolidación atelectásica parcial del lóbulo inferior. También se visualiza discreto derrame pleural izquierdo". Evaluado por Cirugia y Broncopulmonar se determina manejo con Ceftriaxona. El 23/01/24 se rescata UC (+) E faecalis, por lo que completa 6 dias con Ampicilina. El 28/01/2024 sufre compromiso de conciencia, evaluado por residente de Medicina, paciente con bradicardia al monitor impresiona ausencia de ritmo marcapasos. Se apoya con marcapasos externo, TAC de cerebro sin lesiones agudas. Evaluado por Residente UTI, paciente em glasgow 15 puntos, se decide ingreso para monitorizacion y eventual instalación de Marcapasos Transitorio. Tras monitorizacion de > 12 hrs paciente se mantiene con FC > 65, al monitor FA. Sin necesidad de instalación de MCP transitorio. es llevado a poli marcapasos en HCHM donde encuentran marcapasos funcionando correctamente, se aumenta volataje. sin otro incidente, se mantiene con manejo antibiotico en manejo medico caso discutido por cirujanos y broncopulmonar.
Por favorable evolución global se decide su alta en concepto de hospitaLizacion domiciliaria con el objeto de

asegurar terapia kinesica respiratoria x 5 a dias

PLAN DE MANEJO:

ALTA EN MODELO DE H DOMICILIARIA PARA APOYO KNT RESP
COMPLETAR AL MENOS 21 DIAS DE TTO ANTIBIOTICO
CONTROL POLI CIRUGIA 10 DIAS PARA CONTROL EMPIEMA CON EXS Y RXTX
RETOMAR SUS CONTROLES HABITUALES

INDICACIONES AL ALTA

1. REPOSO RELATIVO
2. REGIMEN DIABETICO HIPOSODICO, RESTRICCION HIDRICA
3. OMEPRAZOL COMPRIMIDO 20 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 24 hrs. por 30 dias via ORAL
4. FUROSEMIDA COMPRIMIDO 40 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 24 hrs. por 30 dias via ORAL
5. TAMSULOSINA COMPRIMIDO 0,4 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 24 hrs. por 30 dias via ORAL
6. AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO COMPRIMIDO 875 MILÍGRAMOS / 125 MILÍGRAMOS 1 comprimido cada 12 hrs. por 12 dias via ORAL
7. PREGABALINA COMPRIMIDO 75 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 24 hrs. por 30 dias via ORAL NOCHE
8. CALCIO CARBONATO COMPRIMIDO 1125 MILÍGRAMOS / 175 MILÍGRAMOS 1 comprimido cada 24 hrs. por 30 dias via ORAL
9. ZOLPIDEN COMPRIMIDO 10 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 24 hrs. por 30 dias via ORAL NOCHE
10. IPRATROPIO INHALADOR FRASCO UNIDAD 2 frasco cada 6 hrs. por 30 dias via INHALATORIA
11. SALBUTAMOL INHALADOR 100 MICROGRAMOS / DOSIS 2 inhalador cada 8 hrs. por 30 dias via INHALATORIA

EXÁMENES Y RESULTADOS

RXTX 30.1.24 CARDIOMEGALIA SIGNIFICATIVA Y DERRAME PLURAL RESIDUAL A DER
EXS 1.2.24 -> ALB 2.4, PCR 34, CREA 1.3, NA 134, K 4.7, HB 11.6, PLT 119000, GB 3000, INR 1.1

CALDERON SOLIS CRISTIAN JOSE
MEDICO TRATANTE
15161784-0

JEFE SERVICIO